PRÜFUNGSTRAINING · SCHRIFTLICHE PRÜFUNG

Probeklausur Pflegeexamen

8 Fallsituationen und 3 Großfälle mit 68 fallbezogenen Aufgaben – so, wie im Examen gefragt wird: Situation lesen, einschätzen, richtig handeln.

Bestehen ist planbar.

Fallbezogen · Großfälle · Erklärungen · Lösungsschlüssel

68	11	A4
Aufgaben	Fälle	druckfertig

INHALT

1. Teil A: Fallsituationen
2. Teil B: Großfälle
3. Lösungen mit Begründung
4. Auswertung

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

So nutzt du die Probeklausur

Bearbeite die Aufgaben am Stück und ohne Hilfsmittel – wie in der echten Prüfung. Plane etwa zwei Minuten pro Aufgabe ein. Erst danach in den Lösungsteil schauen.

TEIL A

Kurze Fallsituationen aus Krankenhaus, Pflegeheim und ambulanter Pflege – je mehrere Aufgaben zu einem Fall.

TEIL B

Große Fälle, die sich über Aufnahme, Verlauf und Entlassung entwickeln – wie im Examen.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

A Fallsituationen

Lies jeden Fall genau – die Antworten stecken oft in den Details.

FALL 1 · KRANKENHAUS, INTERNISTISCHE STATION

Herzinsuffizienz, 74-jähriger Mann

Herr K., 74 Jahre, wird mit zunehmender Luftnot und geschwollenen Beinen stationär aufgenommen. Er berichtet, nachts schlecht flach liegen zu können und in den letzten 3 Tagen 2,5 kg zugenommen zu haben. RR 158/94 mmHg, Puls 96/min unregelmäßig, SpO2 90 % bei Raumluft, Atemfrequenz 24/min. Bekannt sind eine chronische Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern.

1 **Welche Beobachtung deutet am deutlichsten auf eine kardiale Dekompensation mit Flüssigkeitseinlagerung hin?** ●●

- A Die Gewichtszunahme von 2,5 kg in 3 Tagen
- B Der unregelmäßige Puls
- C Der erhöhte Blutdruck
- D Das Alter des Patienten

2 **Welche Lagerung entlastet Herrn K. bei akuter Luftnot am wirksamsten?** ●

- A Flache Rückenlage
- B Oberkörperhochlagerung mit hängenden Beinen (Herzbettlagerung)
- C Stabile Seitenlage
- D Kopftieflagerung

3 **Herr K. soll bilanziert werden. Was gehört zwingend zur korrekten Flüssigkeitsbilanzierung?** ●●

- A Nur die Trinkmenge dokumentieren
- B Nur die Urinausscheidung messen
- C Ein- und Ausfuhr vollständig erfassen und gegenüberstellen
- D Einmal täglich den Blutdruck messen

4 **Welche Kombination von Vitalwerten sollte umgehend an den Arzt gemeldet werden?** ●●

- A RR 120/80, Puls 72, SpO2 98 %, AF 14
- B RR 130/85, Puls 80, SpO2 96 %, AF 16
- C RR 125/78, Puls 68, SpO2 97 %, AF 15
- D RR 158/94, Puls 96, SpO2 90 %, AF 24

FALL 2 · KRANKENHAUS, CHIRURGISCHE STATION

Erster postoperativer Tag nach Hüft-TEP, 68-jährige Frau

Frau M., 68 Jahre, ist am Vortag mit einer Hüft-Totalendoprothese versorgt worden. Am ersten postoperativen Tag klagt sie über Schmerzen (NRS 6/10) und möchte lieber im Bett bleiben. Der Verband ist trocken, die Wunddrainage fördert mäßig blutig. RR 110/70, Puls 88, Temperatur 37,8 Grad.

5 **Warum ist die Frühmobilisation trotz der Schmerzen wichtig?**

- A Sie senkt das Risiko für Thrombose, Pneumonie und Dekubitus
- B Sie beschleunigt die Wundheilung direkt
- C Sie ist nur aus Kostengründen vorgeschrieben
- D Sie ersetzt die Schmerztherapie

6 **Was ist vor der geplanten Mobilisation pflegerisch am wichtigsten?**

- A Die Patientin überreden, es einfach zu versuchen
- B Eine bedarfsgerechte Schmerzmedikation nach Anordnung rechtzeitig verabreichen
- C Die Drainage sofort ziehen
- D Die Mobilisation auf den nächsten Tag verschieben

7 **Bei welchem Zeichen besteht der Verdacht auf eine tiefe Beinvenenthrombose?**

- A Beidseitig warme Füße
- B Trockener Wundverband
- C Einseitige Schwellung, Überwärmung und Schmerz der Wade
- D Temperatur von 37,8 Grad

8 **Die Wunddrainage fördert plötzlich stark hellrot und die Patientin wird blass und tachykard. Wie handelst du?**

- A Abwarten und in einer Stunde erneut kontrollieren
- B Die Drainage abklemmen und nichts dokumentieren
- C Der Patientin etwas zu trinken geben
- D Vitalzeichen kontrollieren und umgehend den Arzt informieren

FALL 3 · STATIONÄRE LANGZEITPFLEGE

Verwirrtheit bei 85-jähriger Bewohnerin

Frau S., 85 Jahre, lebt seit zwei Jahren im Pflegeheim und ist normalerweise orientiert und freundlich. Seit gestern ist sie zunehmend verwirrt, zeitlich und örtlich desorientiert, unruhig und sieht Dinge, die nicht da sind. Sie hat seit zwei Tagen wenig getrunken und klagt beim Wasserlassen über Brennen.

9 **Welche Ursache der plötzlichen Verwirrtheit ist bei diesem Verlauf am wahrscheinlichsten?**

- A Ein akutes Delir, möglicherweise durch Harnwegsinfekt und Exsikkose
- B Eine beginnende Demenz
- C Normale Alterserscheinung
- D Eine psychische Erkrankung, die schon lange besteht

10 **Was ist die wichtigste pflegerische Sofortmaßnahme?**

- A Die Bewohnerin fixieren, damit sie sich nicht verletzt
- B Reizarme, sichere Umgebung schaffen, Flüssigkeit anbieten und den Arzt informieren
- C Sie allein lassen, bis sie sich beruhigt
- D Ihr ein Schlafmittel geben

11 **Welche Maßnahme beugt einem erneuten Delir am besten vor?**

- A Möglichst viel Bettruhe
- B Die Bewohnerin täglich testen
- C Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Tag-Nacht-Rhythmus, Brille und Hörgerät, Reorientierung
- D Besuche der Angehörigen verbieten

12 **Warum ist die reduzierte Trinkmenge bei alten Menschen besonders kritisch?**

- A Alte Menschen brauchen kaum Flüssigkeit
- B Trinken spielt im Alter keine Rolle
- C Nur die Nahrungsmenge ist wichtig
- D Das Durstempfinden ist im Alter vermindert, wodurch ein Flüssigkeitsmangel leicht übersehen wird

FALL 4 · KRANKENHAUS, KINDERSTATION

Fieberkrampf-Sorge bei 3-jährigem Kind

Der 3-jährige Tim wird mit hohem Fieber (39,6 Grad) und einem Infekt der oberen Atemwege aufgenommen. Die Mutter ist sehr beunruhigt, weil Tim vor einer Stunde kurz 'komisch gezuckt' habe und danach schläfrig gewesen sei. Tim ist jetzt wach, trinkt aber wenig.

13 **Wie begegnest du der beunruhigten Mutter am besten?**

- A Ruhig zuhören, die Sorge ernst nehmen und über das weitere Vorgehen informieren
- B Ihr sagen, sie solle sich nicht so anstellen
- C Das Thema wechseln
- D Sie aus dem Zimmer schicken

14 **Welche Maßnahme ist bei hohem Fieber pflegerisch sinnvoll?**

- A Das Kind warm einpacken
- B Ausreichend Flüssigkeit anbieten und nach Anordnung fiebersenkende Maßnahmen durchführen
- C Kaltes Wasser über das Kind gießen
- D Nichts tun und abwarten

15 **Was ist bei der Beobachtung eines fieberhaften Kleinkindes besonders zu beachten?**

- A Nur die Körpertemperatur
- B Ausschließlich das Gewicht
- C Bewusstseinslage, Trinkverhalten, Hautkolorit und Atmung im Verlauf
- D Nur die Herzfrequenz

16 **Warum trinkt Tim zu wenig - und warum ist das ein Problem?**

- A Kinder brauchen wenig Flüssigkeit; das ist unkritisch
- B Trinken ist bei Kindern nebensächlich
- C Nur feste Nahrung zählt
- D Fieber und Infekt erhöhen den Bedarf, während krankheitsbedingt weniger getrunken wird - Dehydratationsgefahr

FALL 5 · PSYCHIATRISCHE KLINIK

Antriebslosigkeit bei 22-jährigem Patienten mit Depression

Herr L., 22 Jahre, ist wegen einer schweren depressiven Episode aufgenommen. Er bleibt fast den ganzen Tag im Bett, spricht wenig, vernachlässigt die Körperpflege und äußert, dass 'alles sinnlos' sei. Beim Morgengespräch sagt er leise, er wisse nicht, ob er 'das alles noch durchhalten' könne.

17 **Wie reagierst du auf die Äußerung, er wisse nicht, ob er 'das durchhalten' könne?** ●●●

- A Ihn direkt, ruhig und wertschätzend auf mögliche Suizidgedanken ansprechen
- B Die Aussage ignorieren, um ihn nicht zu beunruhigen
- C Ihm sagen, er solle positiv denken
- D Das Thema wechseln

18 **Wie förderst du die Körperpflege bei ausgeprägter Antriebslosigkeit am besten?** ●●

- A Die Pflege komplett für ihn übernehmen
- B Kleinschrittig anleiten, Aktivitäten anbieten und erreichbare Ziele setzen
- C Ihn zur Pflege zwingen
- D Die Körperpflege ganz weglassen

19 **Welche Haltung ist im Umgang mit depressiven Menschen grundlegend?** ●●

- A Aufmunternde Sprüche wie 'Kopf hoch, wird schon'
- B Distanz halten, um nicht zu belasten
- C Empathisches, geduldiges Dasein ohne Bagatellisieren der Beschwerden
- D Leistung einfordern

20 **Warum ist gerade die Phase beginnender Besserung bei Depression besonders zu beobachten?** ●●●

- A Weil dann keine Gefahr mehr besteht
- B Weil die Behandlung dann endet
- C Weil Beobachtung dann überflüssig wird
- D Weil mit wiederkehrendem Antrieb das Suizidrisiko vorübergehend steigen kann

FALL 6 · KRANKENHAUS, AKUTSITUATION

Akute Verschlechterung, ABCDE-Einschätzung

Du betrittst das Zimmer und findest Frau B., 59 Jahre, deutlich verschlechtert vor: Sie ist nur noch schwer erweckbar, atmet schnell und flach, die Lippen wirken bläulich. Du bist allein im Zimmer.

21 **Was ist dein allererster Schritt?** ●●

- A Ansprechbarkeit prüfen und Hilfe rufen / Notruf absetzen
- B Die Blutdruckmanschette anlegen
- C Erst die Kurve lesen
- D Die Angehörigen anrufen

22 **Nach welchem Schema schätzt du die Situation strukturiert ein?**

- A Von Kopf bis Fuß ohne Reihenfolge
- B ABCDE: Atemweg, Atmung, Kreislauf, neurologischer Status, Umgebung
- C Zuerst die Haut, dann alles Weitere
- D Nur die Sauerstoffsättigung

23 **Die bläulichen Lippen deuten worauf hin?**

- A Auf Fieber
- B Auf Kälte im Zimmer allein
- C Auf eine Zyanose als Zeichen von Sauerstoffmangel
- D Auf eine harmlose Verfärbung

24 **Welche Information ist bei der Übergabe an das eintreffende Team am wichtigsten?**

- A Das Lieblingsessen der Patientin
- B Nur der Name
- C Die Zimmernummer allein
- D Strukturierte Übergabe: Situation, Vitalzeichen, Bewusstsein, bisherige Maßnahmen

FALL 7 · PALLIATIVVERSORGUNG / HOSPIZ

Belastende Atemnot bei palliativer Patientin, 71 Jahre

Frau W., 71 Jahre, befindet sich in der letzten Lebensphase bei fortgeschrittener Tumorerkrankung. Sie leidet unter belastender Atemnot und Angst. Die Angehörigen sind anwesend und wirken hilflos und überfordert.

25 **Was steht in der palliativen Pflege bei belastender Atemnot im Vordergrund?**

- A Linderung der Symptome und des Leidens (Symptomkontrolle, Comfort)
- B Die vollständige Heilung anzustreben
- C Möglichst viele diagnostische Maßnahmen
- D Die Patientin zur Mobilisation drängen

26 **Welche pflegerische Maßnahme kann die Atemnot unmittelbar lindern?**

- A Flachlagerung
- B Oberkörperhochlagerung, ruhige Präsenz, frische Luft / kühler Luftzug
- C Das Fenster schließen und allein lassen
- D Zur Eile drängen

27 **Wie beziehst du die überforderten Angehörigen ein?**

- A Sie aus dem Zimmer bitten
- B Ihnen sagen, sie sollen sich zusammenreißen
- C Sie behutsam informieren, einfache Aufgaben anbieten und ihre Gefühle zulassen
- D Sie ignorieren

28 **Welche Haltung ist in der Sterbebegleitung zentral?**

- A Sachliche Distanz ohne Nähe
- B Die Patientin möglichst wenig stören, also gar nicht ins Zimmer gehen
- C Ausschließlich körperliche Pflege
- D Würde wahren, zuhören, da sein und individuelle Wünsche respektieren

FALL 8 · AMBULANTE PFLEGE, HÄUSLICHES UMFELD

Diabetisches Fußulkus bei 66-jährigem Mann zu Hause

Herr D., 66 Jahre, mit langjährigem Diabetes mellitus Typ 2, wird ambulant versorgt. Beim Hausbesuch entdeckst du an seinem rechten Fuß eine gerötete, druckempfindliche Stelle mit beginnender offener Wunde. Herr D. sagt, er habe davon nichts gespürt. Er lebt allein und kocht selten frisch.

29 **Warum hat Herr D. die Wunde nicht gespürt?**

- A Eine diabetische Polyneuropathie kann das Schmerz- und Druckempfinden herabsetzen
- B Er stellt sich unempfindlich
- C Die Wunde tut grundsätzlich nicht weh
- D Er hat zu dicke Socken getragen

30 **Was ist bei der Wundstelle pflegerisch vorrangig?**

- A Die Stelle fest verbinden und abwarten
- B Druckentlastung, fachgerechte Wundversorgung und ärztliche Abklärung veranlassen
- C Ein Hausmittel auftragen
- D Die Wunde offen lassen und nichts weiter tun

31 **Welche Beratung ist für Herrn D. zur Vorbeugung am wichtigsten?**

- (A) Barfuß laufen zur Abhärtung
- (B) Die Füße möglichst wenig anschauen
- (C) Tägliche Fußinspektion, gut passendes Schuhwerk und regelmäßige Fußpflege
- (D) Enge Schuhe tragen

32 **Herr D. lebt allein und kocht selten frisch. Welcher weitere Aspekt ist relevant?**

- (A) Das ist ohne Bedeutung
- (B) Nur die Wunde zählt
- (C) Er sollte einfach mehr essen
- (D) Ernährungssituation und Blutzuckereinstellung beeinflussen Wundheilung und Verlauf - ggf. weitere Unterstützung organisieren

B1 Großfall

KRANKENHAUS, INTERNISTISCHE STATION

Herr Berger, 78 Jahre - dekompensierte Herzinsuffizienz

Herr Berger, 78 Jahre, wird vom Hausarzt mit zunehmender Luftnot und geschwollenen Beinen eingewiesen. Er lebt allein, seine Frau ist vor einem Jahr verstorben. Bekannt sind eine chronische Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und ein leichter Diabetes mellitus Typ 2. Bei Aufnahme: RR 165/95 mmHg, Puls 98/min unregelmäßig, SpO2 89 % bei Raumluft, Atemfrequenz 26/min, Temperatur 36,8 Grad. Er kann nur mit erhöhtem Oberkörper atmen.

AUFNAHME

33 **Welches Aufnahmezeichen weist am deutlichsten auf eine akute kardiale Dekompensation mit Sauerstoffmangel hin?**

- A Die SpO2 von 89 % mit erhöhter Atemfrequenz
- B Die Temperatur von 36,8 Grad
- C Der unregelmäßige Puls
- D Das Alter von 78 Jahren

34 **Wie lagerst du Herrn Berger bei der Aufnahme, um seine Atmung zu erleichtern?**

- A Eine flache Rückenlage ganz ohne Erhöhung des Oberkörpers
- B Herzbettlagerung: Oberkörper hoch, Beine tief
- C Die stabile Seitenlage wie bei bewusstlosen Patienten
- D Eine durchgehende Bauchlage zur Entlastung des Rückens

ASSESSMENT

35 **Der Arzt ordnet eine Flüssigkeitsbilanzierung an. Was erfasst du dafür vollständig?**

- A Nur die Trinkmenge
- B Nur die Urinausscheidung
- C Gesamte Ein- und Ausfuhr im Vergleich
- D Nur das Körpergewicht

36 **Warum ist bei Herrn Berger das tägliche Wiegen besonders aussagekräftig?**

- A Weil er im Rahmen der Behandlung gezielt abnehmen soll
- B Weil das Körpergewicht die genaue Medikamentendosis bestimmt
- C Weil sich daran die Einstellung seines Diabetes ablesen lässt
- D Weil eine rasche Gewichtszunahme Flüssigkeitseinlagerung anzeigt

MASSNAHMEN

37 **Herr Berger erhält nach Anordnung ein Diuretikum. Welche Beobachtung ist jetzt besonders wichtig?** ●●●

- A Urinausscheidung, Elektrolyte und Kreislauf
- B Ausschließlich die Farbe und das Aussehen der Haut
- C Ausschließlich die gemessene Körpertemperatur
- D Ausschließlich das täglich erfasste Körpergewicht

38 **Herr Berger möchte trotz Luftnot nachts allein zur Toilette. Wie handelst du sicher?** ●●

- A Ihm das nächtliche Aufstehen zur Toilette streng verbieten
- B Sturzrisiko einschätzen, Hilfe anbieten, Rufanlage in Reichweite legen
- C Ihn ganz ohne weitere Sicherungsmaßnahmen gewähren lassen
- D Ein hochgestelltes Bettgitter allein als ausreichende Maßnahme ansehen

VERSCHLECHTERUNG

39 **In der zweiten Nacht wird Herr Berger plötzlich stark kurzatmig, hustet schaumig-rosa Sekret und hat Todesangst. Was vermutest du?** ●●●

- A Eine Erkältung
- B Normale nächtliche Unruhe
- C Ein akutes Lungenödem
- D Eine Magenverstimmung

40 **Was ist deine erste Maßnahme bei Verdacht auf ein akutes Lungenödem?** ●●●

- A Flach hinlegen und abwarten
- B Ihm etwas zu trinken geben
- C Ihn allein lassen und später kontrollieren
- D Oberkörper hoch, Beine tief, Hilfe rufen und beruhigen

41 **Welche Vitalzeichen-Kombination bestätigt die kritische Verschlechterung am deutlichsten?** ●●

- A SpO2 82 %, AF 34, Puls 118, RR 180/100
- B RR 130/80, Puls 76, SpO2 97 %, AF 15
- C RR 120/75, Puls 70, SpO2 98 %, AF 14
- D SpO2 95 %, AF 18, Puls 82, RR 135/85

STABILISIERUNG

42 **Nach ärztlicher Behandlung stabilisiert sich Herr Berger. Was gehört jetzt zur pflegerischen Überwachung?**

- A Keine weitere Beobachtung nötig
- B Engmaschige Vitalzeichen, Atmung, Bilanz und Bewusstsein
- C Nur einmal täglich Blutdruck
- D Nur das Gewicht am Entlassungstag

ENTLASSUNG

43 **Zur Entlassung berätst du Herrn Berger. Welcher Hinweis ist zur Vermeidung einer erneuten Dekompensation zentral?**

- A Sich möglichst wenig bewegen und körperliche Schonung einhalten
- B Reichlich salzhaltige Speisen zur Kreislaufanregung essen
- C Täglich wiegen und bei rascher Zunahme den Arzt kontaktieren
- D Die verordneten Medikamente bei einsetzender Besserung absetzen

44 **Herr Berger lebt allein und wirkt seit dem Tod seiner Frau niedergeschlagen. Was ist pflegerisch angemessen?**

- A Das ist seine Privatsache und für die Pflege nicht von Bedeutung
- B Ihn dazu auffordern, sich zusammenzureißen und nach vorn zu blicken
- C Ausschließlich die körperlichen Aspekte seiner Erkrankung beachten
- D Die psychosoziale Situation ernst nehmen und Unterstützung (z. B. ambulante Hilfen, Gespräch) anbieten

B2 Großfall

KRANKENHAUS, CHIRURGISCHE STATION NACH OP

Frau Cakir, 24 Jahre - nach Verkehrsunfall und Bein-OP

Frau Cakir, 24 Jahre, wurde nach einem Fahrradunfall mit einem offenen Unterschenkelbruch operiert (Osteosynthese). Sie kommt am OP-Tag auf die Station. Sie hat starke Schmerzen (NRS 7/10), ist blass und ängstlich. Der Wundverband am rechten Unterschenkel ist trocken, eine Redon-Drainage fördert mäßig blutig. RR 105/65, Puls 92, Temperatur 37,2 Grad. Sie fragt immer wieder, ob ihr Bein 'wieder normal' werde.

AUFNAHME

45 **Frau Cakir hat NRS 7/10. Was ist deine vorrangige Maßnahme?**

- A Schmerzmedikation nach Anordnung zeitnah verabreichen und Wirkung kontrollieren
- B Sie freundlich bitten, die Schmerzen noch eine Weile auszuhalten
- C Erst am Abend im Rahmen der Routineversorgung darauf reagieren
- D Sie ausschließlich durch Gespräche vom Schmerz ablenken

46 **Frau Cakir ist blass und tachykard. Welche Ursache musst du postoperativ zuerst ausschließen?**

- A Ein einfaches Hungergefühl aufgrund der längeren Nüchternheit
- B Eine Nachblutung / beginnender Volumenmangel
- C Eine harmlose Langeweile nach dem langen Liegen im Bett
- D Eine zu warm eingestellte Bettdecke mit leichtem Wärmestau

ASSESSMENT

47 **Wie kontrollierst du die Durchblutung, Motorik und Sensibilität (DMS) am operierten Bein?**

- A Gar nicht, da diese Kontrolle ausschließlich der Arzt durchführt
- B Ausschließlich den angelegten Verband von außen ansehen
- C Hautfarbe/Temperatur, Zehenbeweglichkeit und Gefühl regelmäßig prüfen und vergleichen
- D Nur ein einziges Mal am Tag der geplanten Entlassung

48 **Welches Zeichen am operierten Unterschenkel würde dich an ein Kompartmentsyndrom denken lassen?**

- A Ein leichtes Ziehen, das auf die übliche Schmerzmedikation gut anspricht
- B Ein durchgehend trockener und sauber sitzender Wundverband
- C Eine gemessene Körpertemperatur von rund 37,2 Grad
- D Zunehmender, kaum beeinflussbarer Schmerz, praller Unterschenkel, Gefühlsstörung

MASSNAHMEN

49 **Welche Prophylaxen sind bei Frau Cakir postoperativ besonders wichtig?** ●●

- A Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe
- B Ausschließlich die Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubitus)
- C Gar keine Prophylaxen, da sie noch jung und belastbar ist
- D Ausschließlich die Vorbeugung von Stürzen bei Mobilisation

50 **Bei der ersten Mobilisation wird Frau Cakir schwindelig und blass. Wie reagierst du?** ●●

- A Sie trotz der Beschwerden zum Weitergehen und Durchhalten drängen
- B Mobilisation stoppen, sicher hinsetzen/lagern, Vitalzeichen und Kreislauf kontrollieren
- C Sie zur weiteren Kreislaufanregung kurz allein stehen lassen
- D Zunächst nur das Fenster öffnen und die Entwicklung abwarten

VERSCHLECHTERUNG

51 **Am dritten Tag klagt Frau Cakir über plötzliche Atemnot und stechenden Brustschmerz beim Einatmen. Woran musst du denken?** ●●●

- A Muskelkater
- B Sodbrennen
- C Eine Lungenembolie
- D Aufregung wegen Besuch

52 **Wie verhältst du dich bis zum Eintreffen des Arztes bei Verdacht auf Lungenembolie?** ●●●

- A Die Patientin flach hinlegen und zur Beobachtung allein lassen
- B Sie zur Förderung des Kreislaufs zur Mobilisation auffordern
- C Ihr zur Stärkung zunächst etwas zu essen anbieten
- D Oberkörper hoch, beruhigen, Vitalzeichen/SpO2 überwachen, Sauerstoff nach Anordnung

STABILISIERUNG

53 **Frau Cakir äußert nach dem Zwischenfall große Angst, erneut etwas 'Schlimmes' zu bekommen. Wie begegnest du ihr?** ●●

- A Angst ernst nehmen, altersgerecht informieren und Sicherheit durch Präsenz und Aufklärung geben
- B Ihre geäußerte Angst als deutlich übertrieben abtun
- C Das belastende Thema meiden und bewusst nicht ansprechen
- D Ihr sagen, sie solle einfach nicht so viel darüber nachdenken

REHABILITATION

54 **Frau Cakir sorgt sich um die Zukunft ihres Beins. Welche Haltung ist angemessen?**

- A Ihr eine vollständige Heilung garantieren
- B Ehrlich, aber zuversichtlich informieren und auf das Reha-Team verweisen
- C Sagen, das wisse niemand, und das Thema beenden
- D Ihr raten, sich keine Hoffnung zu machen

55 **Welche Beobachtung an der OP-Wunde würde auf eine Wundinfektion hindeuten?**

- A Ein durchgehend trockener und reizloser Wundverband
- B Ein leichter Juckreiz, der erst nach einigen Tagen auftritt
- C Zunehmende Rötung, Überwärmung, Schwellung, Schmerz und ggf. Fieber
- D Eine blasse, unauffällige Narbe nach mehreren Wochen

ENTLASSUNG

56 **Zur Entlassung: Welcher Hinweis zur Thromboseprophylaxe zu Hause ist wichtig?**

- A Strikte Bettruhe halten, bis die Wunde vollständig verheilt ist
- B Die verordnete Prophylaxe sofort nach der Entlassung beenden
- C Möglichst viel mit hängenden Beinen sitzen und sich schonen
- D In Bewegung bleiben, verordnete Prophylaxe (z. B. Spritzen/Strümpfe) korrekt fortführen

B3 Großfall

AMBULANTE PSYCHIATRISCHE PFLEGE

Herr Novak, 55 Jahre - Depression nach Jobverlust

Herr Novak, 55 Jahre, wird nach einem Klinikaufenthalt wegen einer schweren depressiven Episode ambulant weiterbetreut. Er hat vor einem Jahr seinen Arbeitsplatz verloren, lebt getrennt und hat wenig sozialen Kontakt. Beim ersten Hausbesuch wirkt die Wohnung ungepflegt, er ist unrasiert, spricht leise und verlangsamt. Er sagt, er nehme seine Medikamente 'meistens', und Essen sei ihm 'egal'.

ERSTKONTAKT

57 **Welche Grundhaltung ist beim Erstkontakt mit Herrn Novak am wichtigsten?** ●

- A Empathisch, geduldig und wertschätzend eine Beziehung aufbauen
- B Ihn mit Aufgaben unter Druck setzen
- C Ihm sagen, er solle sich zusammenreißen
- D Distanziert nur die Fakten abfragen

58 **Herr Novak sagt, Essen sei ihm 'egal'. Warum ist das pflegerisch bedeutsam?** ●●

- A Es ist unwichtig, solange er seine Medikamente zuverlässig einnimmt
- B Appetitverlust und Vernachlässigung können Krankheitszeichen sein und die Gesundheit gefährden
- C Ausschließlich sein aktuelles Körpergewicht ist dabei entscheidend
- D Das betrifft allein den behandelnden Arzt und nicht die Pflege

ASSESSMENT

59 **Er berichtet, die Medikamente nur 'meistens' zu nehmen. Wie gehst du damit um?** ●●

- A Ihn wegen der unregelmäßigen Einnahme beschuldigen und ermahnen
- B Ihm die Medikamente ohne sein Wissen heimlich ins Essen geben
- C Nicht-wertend nach Gründen fragen und über die Bedeutung der regelmäßigen Einnahme informieren
- D Die unregelmäßige Einnahme übergehen und nicht ansprechen

60 **Welche Aussage von Herrn Novak erfordert deine höchste Aufmerksamkeit?** ●●●

- A Die Aussage, dass er in letzter Zeit sehr schlecht schlafe
- B Die Aussage, dass er kaum noch Appetit auf Essen habe
- C Die Aussage, dass er sich tagsüber oft müde und erschöpft fühle
- D 'Manchmal denke ich, es wäre besser, nicht mehr da zu sein.'

KRISE

61 **Du sprichst ihn direkt auf Suizidgedanken an. Warum ist dieses offene Nachfragen richtig?** ●●●

A Offenes Ansprechen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und ermöglicht Hilfe

B Das offene Ansprechen bringt ihn erst auf entsprechende Gedanken

C Ein solches Thema sollte man im Gespräch besser ganz vermeiden

D Über Suizidgedanken darf ausschließlich der Arzt sprechen

62 **Herr Novak bestätigt Suizidgedanken, verneint aber einen konkreten Plan. Was ist jetzt richtig?** ●●●

A Den Hausbesuch wie geplant in Ruhe und ohne weitere Schritte zu Ende bringen

B Situation ernst nehmen, nicht allein lassen bzw. Sicherheit organisieren und umgehend ärztliche/therapeutische Hilfe einbeziehen

C Ihm ein Beruhigungsmittel aus der eigenen Hausapotheke zur Entspannung anbieten

D Das belastende Thema erst beim nächsten vereinbarten Hausbesuch wieder aufgreifen

STABILISIERUNG

63 **In den folgenden Wochen bessert sich Herr Novaks Antrieb, die Stimmung bleibt aber gedrückt. Warum ist gerade jetzt Aufmerksamkeit wichtig?** ●●●

A Weil mit der Besserung nun keinerlei Gefahr mehr besteht

B Weil die pflegerische Betreuung an dieser Stelle regulär endet

C Weil mit zurückkehrendem Antrieb das Suizidrisiko vorübergehend steigen kann

D Weil eine weitere Beobachtung jetzt überflüssig geworden ist

FÖRDERUNG

64 **Wie förderst du Herrn Novaks Selbstversorgung (Körperpflege, Haushalt) am besten?** ●●

A Ihm sämtliche anfallenden Aufgaben vollständig abnehmen

B Ihn nachdrücklich zu allen Tätigkeiten gleichzeitig drängen

C Es ihm ganz allein überlassen, ohne jede Unterstützung

D Kleinschrittig aktivieren, erreichbare Ziele setzen und Erfolge anerkennen

65 **Welche Maßnahme wirkt der sozialen Isolation von Herrn Novak entgegen?** ●●

A Gemeinsam Kontakt- und Tagesstrukturangebote (z. B. Tagesstätte, Gruppen) erarbeiten

B Ihm raten, sich zum Schutz besser weiter zurückzuziehen

C Besuche bei ihm grundsätzlich und möglichst ganz vermeiden

D Ihn ohne Rücksicht zu sozialen Kontakten drängen und zwingen

VERLAUF

66 **Herr Novak fragt, ob er die Medikamente absetzen könne, da es ihm besser gehe. Wie antwortest du?**

- A 'Ja, wenn Sie sich deutlich besser fühlen, können Sie damit aufhören.'
- B 'Das entscheidet der Arzt - Antidepressiva werden nicht eigenmächtig abgesetzt, auch bei Besserung.'
- C 'Nehmen Sie ab jetzt einfach nur noch die halbe Dosis ein.'
- D 'Ob Sie die Medikamente nehmen, ist letztlich Ihre eigene Sache.'

ANGEHÖRIGE

67 **Herrn Novaks erwachsene Tochter meldet sich und möchte helfen, weiß aber nicht wie. Was ist sinnvoll?**

- A Ihr mitteilen, sie solle sich aus der Behandlung heraushalten
- B Ihr auch ohne seine Zustimmung alle Einzelheiten weitergeben
- C Sie - mit Einverständnis von Herrn Novak - einbeziehen und über unterstützenden Umgang informieren
- D Ihr Angebot übergehen und die Tochter nicht weiter einbeziehen

VERLAUF

68 **Woran erkennst du insgesamt, dass die ambulante psychiatrische Pflege bei Herrn Novak wirkt?**

- A Dass er im weiteren Verlauf eher zufällig wieder etwas an Körpergewicht zunimmt
- B Dass er in den Gesprächen insgesamt deutlich weniger mit dir spricht als anfangs
- C Dass seine Wohnung unverändert im gleichen ungepflegten Zustand bleibt
- D Bessere Selbstversorgung, stabilere Einnahmetreue, mehr Kontakte und Tagesstruktur, keine akute Suizidalität

Lösungen & Begründungen

Richtige Antwort und warum – auch die Begründung, warum die anderen Antworten nicht passen.

Fall 1: Herzinsuffizienz, 74-jähriger Mann

1 **A** Eine rasche Gewichtszunahme ist das sensibelste Zeichen einer Flüssigkeitsretention bei Herzinsuffizienz. Tägliches Wiegen unter gleichen Bedingungen gehört deshalb zur Standardüberwachung. Der unregelmäßige Puls passt zum bekannten Vorhofflimmern, erklärt aber nicht die akute Verschlechterung.

2 **B** Die Herzbettlagerung (Oberkörper hoch, Beine tief) verringert den venösen Rückstrom zum Herzen und senkt die Vorlast, was die Atemarbeit erleichtert. Flaches Liegen verstärkt die Luftnot bei Herzinsuffizienz typischerweise.

3 **C** Eine Flüssigkeitsbilanz erfordert die vollständige Erfassung von Einfuhr (Trinken, Infusionen, Sondenkost) und Ausfuhr (Urin, Drainagen, Erbrechen) und deren Gegenüberstellung. Nur so lässt sich eine positive oder negative Bilanz erkennen.

4 **D** Die erste Kombination zeigt eine Sauerstoffsättigung von nur 90 % bei gleichzeitig erhöhter Atemfrequenz und Herzfrequenz - Zeichen einer respiratorischen Belastung bei Dekompensation. Das erfordert ärztliche Rücksprache und ggf. Sauerstoffgabe nach Anordnung.

Fall 2: Erster postoperativer Tag nach Hüft-TEP, 68-jährige Frau

5 **A** Frühmobilisation ist eine zentrale Prophylaxe: Bewegung aktiviert die Muskelpumpe (Thromboseprophylaxe), verbessert die Belüftung der Lunge (Pneumonieprophylaxe) und entlastet gefährdete Hautstellen (Dekubitusprophylaxe). Voraussetzung ist eine ausreichende Schmerztherapie.

6 **B** Schmerz ist das Haupthindernis der Mobilisation. Eine rechtzeitig - also mit Wirkeintritt vor der Mobilisation - verabreichte Schmerzmedikation nach ärztlicher Anordnung ermöglicht ein schmerzarmes Aufstehen und fördert die Kooperation.

7 **C** Eine einseitige Wadenschwellung mit Überwärmung, Spannungsgefühl und Schmerz ist ein Warnzeichen für eine tiefe Beinvenenthrombose und muss ärztlich abgeklärt werden. Die leicht erhöhte Temperatur allein ist postoperativ zunächst unspezifisch.

8 **D** Eine plötzlich starke hellrote Förderung mit Blässe und Tachykardie kann auf eine Nachblutung mit beginnendem Volumenmangel hindeuten. Vitalzeichen erheben und sofortige ärztliche Information sind zwingend - das ist eine potenziell kritische Situation.

Fall 3: Verwirrtheit bei 85-jähriger Bewohnerin

9 **A** Ein plötzlicher Beginn (Stunden bis Tage), fluktuierender Verlauf, Desorientierung und optische Halluzinationen sprechen für ein Delir - im Gegensatz zur schleichend beginnenden Demenz. Häufige Auslöser bei alten Menschen sind Infekte (hier Harnwegsinfekt) und Flüssigkeitsmangel.

10 **B** Beim Delir gilt: Auslöser behandeln lassen (Arzt informieren), Sicherheit und Reorientierung geben, ausreichend Flüssigkeit anbieten. Fixierung und pauschale Sedierung können ein Delir verschlimmern und sind nur letztes Mittel unter strengen Voraussetzungen.

11 **C** Delirprophylaxe bedeutet, die häufigen Auslöser zu vermeiden: genug trinken, Orientierung fördern (Uhr, Kalender, Tageslicht), Seh- und Hörhilfen bereitstellen und vertraute Bezugspersonen einbeziehen. Immobilität und Isolation erhöhen das Risiko.

12 **D** Im Alter nimmt das Durstempfinden physiologisch ab. Ältere Menschen trinken dadurch oft zu wenig, ohne Durst zu verspüren - eine Exsikkose entsteht schleichend und kann Delir, Sturz und Nierenschäden begünstigen. Aktives Anbieten von Getränken ist deshalb zentral.

Fall 4: Fieberkrampf-Sorge bei 3-jährigem Kind

13 **A** Angehörige - besonders Eltern - brauchen Ernstnahme und Information. Aktives Zuhören, Anerkennen der Sorge und transparente Aufklärung über die nächsten Schritte reduzieren Angst und stärken das Vertrauen. Bagatellisieren ist immer falsch.

14 **B** Bei Fieber steigt der Flüssigkeitsbedarf - regelmäßiges Anbieten kleiner Trinkmengen ist wichtig. Fiebersenkende Maßnahmen (Medikamente, ggf. Wadenwickel) erfolgen nach ärztlicher Anordnung. Warmes Einpacken staut die Wärme, abruptes Abkühlen ist schädlich.

15 **C** Bei Kleinkindern verschlechtert sich der Zustand schnell. Neben der Temperatur sind Bewusstsein, Trinkmenge (Dehydratationsgefahr), Hautfarbe und Atemmuster entscheidend, um eine Verschlechterung frühzeitig zu erkennen.

16 **D** Kinder haben im Verhältnis zum Körpergewicht einen hohen Flüssigkeitsbedarf und dehydrieren schneller als Erwachsene. Fieber steigert den Bedarf zusätzlich. Trinkt das Kind gleichzeitig weniger, droht rasch eine Exsikkose - engmaschige Beobachtung und aktives Anbieten sind nötig.

Fall 5: Antriebslosigkeit bei 22-jährigem Patienten mit Depression

17 **A** Anzeichen möglicher Suizidalität müssen direkt und offen angesprochen werden - das offene Fragen erhöht das Risiko nicht, sondern entlastet und ermöglicht Hilfe. Wichtig sind eine ruhige, wertschätzende Haltung und die umgehende Information des Behandlungsteams.

18 **B** Bei depressionsbedingter Antriebsstörung hilft aktivierende Pflege: kleinschrittige Anleitung, konkrete, erreichbare Ziele und Ermutigung ohne Überforderung. Komplette Übernahme fördert Passivität, Zwang schädigt die Beziehung.

19 **C** Depressive Menschen erleben gut gemeinte Aufmunterung oft als Druck und Unverstandensein. Hilfreich sind Empathie, Geduld, verlässliche Präsenz und das Ernstnehmen der Beschwerden - ohne sie kleinzureden.

20 **D** In der Phase beginnender Besserung kann der Antrieb zurückkehren, bevor sich die Stimmung stabilisiert - dadurch kann das Risiko, Suizidgedanken in die Tat umzusetzen, vorübergehend steigen. Diese Phase erfordert besondere Aufmerksamkeit.

Fall 6: Akute Verschlechterung, ABCDE-Einschätzung

21 **A** Bei einer akut kritischen Situation gilt: Bewusstsein prüfen und sofort Hilfe holen, damit weitere Kräfte und Material kommen. Alleiniges Handeln ohne Hilferuf verzögert die Versorgung. Erst danach folgt die strukturierte Einschätzung.

22 **B** Das ABCDE-Schema priorisiert nach Lebensbedrohlichkeit: A (Airway/Atemweg), B (Breathing/Atmung), C (Circulation/Kreislauf), D (Disability/neurologischer Status), E (Exposure/Umgebung). So wird das Gefährlichste zuerst erkannt und behandelt.

23 **C** Bläuliche Lippen und Haut (Zyanose) sind ein Zeichen für eine unzureichende Sauerstoffversorgung des Blutes. Zusammen mit der schnellen, flachen Atmung und der Bewusstseinstrübung ist das ein Alarmzeichen (Problem bei A/B im ABCDE).

24 **D** Eine strukturierte Übergabe (z. B. nach ISBAR: Situation, Hintergrund, Einschätzung, Empfehlung) mit Vitalzeichen, Bewusstseinslage und bereits ergriffenen Maßnahmen ermöglicht dem Team ein schnelles, sicheres Weiterhandeln.

Fall 7: Belastende Atemnot bei palliativer Patientin, 71 Jahre

25 **A** Palliative Pflege zielt auf bestmögliche Lebensqualität und Linderung von belastenden Symptomen, nicht auf Heilung. Bei Atemnot stehen Symptomkontrolle, beruhigende Präsenz, Lagerung und - nach Anordnung - medikamentöse Linderung im Vordergrund.

26 **B** Eine aufrechte Lagerung erleichtert die Atmung, ruhige Anwesenheit reduziert die Angst (die Atemnot verstärkt), und ein kühler Luftzug (z. B. Ventilator, offenes Fenster) wird von vielen Betroffenen als lindernd empfunden.

27 **C** Angehörige sind Teil der palliativen Begleitung. Behutsame Information, das Angebot einfacher Beteiligung (z. B. Hand halten, Mund befeuchten) und Raum für Gefühle geben Halt und Handlungsfähigkeit in einer belastenden Situation.

28 **D** Sterbebegleitung heißt, die Würde des Menschen zu wahren, zuzuhören, präsent zu sein und individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Zugewandte Nähe und aufmerksame Begleitung sind ebenso wichtig wie die körperliche Versorgung.

Fall 8: Diabetisches Fußulkus bei 66-jährigem Mann zu Hause

29 **A** Bei langjährigem Diabetes schädigt eine Polyneuropathie die Nerven, wodurch Schmerz- und Druckempfinden am Fuß abnehmen. Verletzungen und Druckstellen werden dadurch oft zu spät bemerkt - eine Hauptursache des diabetischen Fußsyndroms.

30 **B** Beim diabetischen Fußulkus sind konsequente Druckentlastung, fachgerechte (aseptische) Wundversorgung und die ärztliche Abklärung entscheidend, um eine Ausbreitung und Infektion zu verhindern. Hausmittel sind ungeeignet.

31 **C** Zur Prophylaxe des diabetischen Fußsyndroms gehören tägliche Kontrolle der Füße (auch mit Spiegel/Angehörigen), passendes, druckfreies Schuhwerk und sorgfältige Fußpflege. Barfußlaufen und enge Schuhe erhöhen das Verletzungsrisiko.

32 **D** Eine unausgewogene Ernährung und schlecht eingestellte Blutzuckerwerte verzögern die Wundheilung erheblich. Die soziale Situation (Alleinleben, seltenes frisches Kochen) ist pflegerelevant - hier können z. B. Ernährungsberatung oder weitere Hilfen sinnvoll sein.

Großfall 1: Herr Berger, 78 Jahre - dekompensierte Herzinsuffizienz

33 **A** Eine SpO2 von 89 % zusammen mit einer Atemfrequenz von 26/min zeigt eine respiratorische Belastung durch die Dekompensation. Der unregelmäßige Puls passt zum bekannten Vorhofflimmern, erklärt aber nicht die akute Luftnot.

34 **B** Die Herzbettlagerung senkt durch die tiefe Beinposition den venösen Rückstrom (Vorlast) und entlastet so das Herz. Der erhöhte Oberkörper erleichtert zusätzlich die Atemarbeit.

35 **C** Eine korrekte Bilanz erfasst die vollständige Einfuhr (Trinken, Infusionen) und Ausfuhr (Urin, Drainagen) und stellt sie gegenüber. Das tägliche Wiegen ergänzt die Bilanz, ersetzt sie aber nicht.

36 **D** Eine kurzfristige Gewichtszunahme ist das sensibelste Zeichen einer Flüssigkeitsretention bei Herzinsuffizienz. Gewogen wird unter gleichen Bedingungen (morgens, nüchtern, gleiche Kleidung).

37 **A** Diuretika steigern die Ausscheidung - dabei können Kalium und andere Elektrolyte entgleisen und der Kreislauf kann bei zu starker Entwässerung absacken. Ausscheidung, Elektrolytwerte (nach Anordnung) und Kreislauf sind zu überwachen.

38 **B** Bei Luftnot, Diuretika (Harndrang) und hohem Alter besteht ein deutliches Sturzrisiko. Sturzassessment, angebotene Begleitung und eine erreichbare Rufanlage erhalten Sicherheit und Selbstbestimmung. Bettgitter allein sind keine Sturzprophylaxe und können freiheitsentziehend sein.

39 **C** Schaumig-rosa (blutig tingiertes) Sekret, akute schwere Luftnot und Angst sind Leitzeichen eines akuten Lungenödems - ein Notfall, der sofortiges Handeln und ärztliche Alarmierung erfordert.

40 **D** Sofort Oberkörper hoch/Beine tief zur Vorlastsenkung, umgehend ärztliche Hilfe holen, Sauerstoff nach Anordnung, ruhige Präsenz gegen die Panik. Flachlagerung würde die Situation verschlimmern.

41 **A** Eine SpO2 von 82 % mit stark erhöhter Atem- und Herzfrequenz sowie hypertensiven Werten zeigt die akute respiratorische und kardiale Krise beim Lungenödem - klar behandlungsbedürftig.

42 **B** Nach einer akuten Dekompensation bleibt die Situation instabil. Engmaschige Kontrolle von Vitalzeichen, Atmung, Flüssigkeitsbilanz und Bewusstsein erkennt eine erneute Verschlechterung frühzeitig.

43 **C** Tägliches Wiegen deckt eine erneute Flüssigkeitseinlagerung frühzeitig auf. Bei rascher Zunahme (z. B. 2 kg in wenigen Tagen) soll ärztlicher Rat gesucht werden. Salzreduktion und Therapietreue sind ebenfalls wichtig - Medikamente werden nie eigenmächtig abgesetzt.

44 **D** Soziale Isolation und Trauer beeinflussen Gesundheit, Selbstversorgung und Therapietreue erheblich. Eine ganzheitliche Pflege nimmt die psychosoziale Situation ernst und vermittelt passende Unterstützungsangebote.

Großfall 2: Frau Cakir, 24 Jahre - nach Verkehrsunfall und Bein-OP

45 **A** Ein Schmerz von 7/10 ist behandlungsbedürftig. Die angeordnete Analgesie wird zeitnah gegeben und die Wirkung nach angemessener Zeit erneut mit der Schmerzskala kontrolliert. Gute Schmerzkontrolle ist Voraussetzung für Mobilisation und Genesung.

46 **B** Blässe und erhöhte Herzfrequenz können nach einer OP Zeichen einer Nachblutung mit Volumenmangel sein. Wichtig sind Kontrolle von Verband, Drainagenmenge, Vitalzeichen und ggf. ärztliche Information. Schmerz und Angst können ebenfalls beitragen.

47 **C** Die DMS-Kontrolle (Durchblutung, Motorik, Sensibilität) erkennt Durchblutungsstörungen oder Nervenschäden frühzeitig. Verglichen wird mit dem gesunden Bein; Auffälligkeiten werden dokumentiert und gemeldet.

48 **D** Ein Kompartmentsyndrom zeigt sich durch unverhältnismäßig starken, auf Analgesie kaum ansprechenden Schmerz, prallgespannte Muskellogen, Gefühls- und später Durchblutungsstörungen. Das ist ein Notfall und muss sofort gemeldet werden.

49 **A** Auch junge Patienten sind durch OP und Immobilität gefährdet. Thromboseprophylaxe (Bewegung, ggf. Medikamente/Strümpfe), Pneumonieprophylaxe (Atemübungen) und Dekubitusprophylaxe (Bewegung, Hautpflege) gehören zum Standard.

50 **B** Schwindel und Blässe bei der ersten Mobilisation deuten auf eine orthostatische Kreislaufreaktion. Die Mobilisation wird unterbrochen, die Patientin sicher gelagert und der Kreislauf kontrolliert. Die nächste Mobilisation erfolgt langsamer und begleitet.

51 **C** Plötzliche Atemnot und atemabhängiger Brustschmerz nach einer Bein-OP sind Warnzeichen einer Lungenembolie (verschleppter Thrombus). Das ist ein lebensbedrohlicher Notfall - sofort Vitalzeichen erheben und ärztliche Hilfe alarmieren.

52 **D** Oberkörperhochlagerung erleichtert die Atmung, ruhige Präsenz reduziert Panik, kontinuierliche Überwachung von Vitalzeichen und Sauerstoffsättigung ist entscheidend. Körperliche Belastung wird vermieden. Sauerstoff nur nach Anordnung.

53 **A** Nach einem bedrohlichen Ereignis ist Angst normal. Ernstnehmen, verständlich informieren und verlässliche Präsenz geben Sicherheit. Gerade bei einer jungen Patientin ist die psychische Verarbeitung Teil der Genesung.

54 **B** Falsche Garantien und Entmutigung sind beide unangebracht. Ehrliche, zugleich zuversichtliche Information im Rahmen der eigenen Kompetenz - und der Verweis auf Physiotherapie und ärztliche Einschätzung - geben realistische Perspektive.

55 **C** Klassische Infektzeichen sind Rötung, Überwärmung, Schwellung, zunehmender Schmerz und Funktionseinschränkung, oft mit Fieber. Sie müssen erkannt, dokumentiert und ärztlich abgeklärt werden.

56 **D** Bewegung aktiviert die Muskelpumpe und beugt Thrombosen vor. Die ärztlich verordnete Prophylaxe (medikamentös und/oder Kompression) wird zu Hause konsequent fortgeführt. Langes Sitzen mit hängenden Beinen und einseitige Bettruhe erhöhen das Risiko.

Großfall 3: Herr Novak, 55 Jahre - Depression nach Jobverlust

57 **A** Vertrauen ist die Basis jeder psychiatrischen Pflege. Empathie, Geduld und Wertschätzung ermöglichen eine tragfähige Beziehung. Druck und Bagatellisierung ('zusammenreißen') schaden und verstärken Rückzug und Scham.

58 **B** Appetitverlust, Antriebsstörung und Selbstvernachlässigung sind typische Symptome der Depression. Sie können zu Mangelernährung und körperlicher Verschlechterung führen - die Ernährungssituation ist deshalb pflegerelevant.

59 **C** Non-Adhärenz hat oft Gründe (Nebenwirkungen, Hoffnungslosigkeit, Vergessen). Ein nicht-wertendes Gespräch, Aufklärung über Wirkung und Wichtigkeit sowie praktische Hilfen (z. B. Dosierhilfe) fördern die Einnahmetreue. Heimliche Gabe ist unzulässig.

60 **D** Äußerungen, die auf lebensmüde Gedanken hindeuten, haben höchste Priorität. Sie müssen ernst genommen und aktiv angesprochen werden, um Suizidalität einzuschätzen und Schutz zu organisieren.

61 **A** Ein verbreiteter Irrtum ist, dass Nachfragen Suizidalität auslöse. Das Gegenteil ist der Fall: Direktes, einfühlsames Ansprechen entlastet Betroffene und ist Voraussetzung, um Gefahr einzuschätzen und Hilfe einzuleiten.

62 **B** Auch ohne konkreten Plan ist Suizidalität ernst. Die Pflegekraft sorgt für Sicherheit, lässt die Person nicht ungeschützt allein und bindet umgehend ärztliche bzw. therapeutische Hilfe ein. Eigenmächtige Medikamentengabe ist unzulässig.

63 **C** In der Phase beginnender Besserung kann der Antrieb zurückkehren, bevor sich die Stimmung stabilisiert. Dadurch kann vorübergehend die Gefahr steigen, Suizidgedanken umzusetzen. Diese Phase erfordert besondere Wachsamkeit.

64 **D** Aktivierende Pflege bei Depression bedeutet, in kleinen, machbaren Schritten zu fördern, realistische Ziele zu vereinbaren und Erreichtes wertzuschätzen. Komplette Übernahme fördert Passivität, Überforderung führt zu Misserfolg.

65 **A** Soziale Isolation verstärkt Depression. Gemeinsam - im Tempo des Betroffenen - Kontaktmöglichkeiten und eine Tagesstruktur zu entwickeln, fördert Teilhabe. Zwang ist kontraproduktiv, Rückzug zu bestärken ebenfalls.

66 **B** Antidepressiva werden auch nach Besserung über längere Zeit weitergenommen und nur in ärztlicher Absprache langsam reduziert. Eigenmächtiges Absetzen erhöht das Rückfallrisiko. Die Pflegekraft informiert und verweist an den Arzt.

67 **C** Angehörige sind eine wichtige Ressource. Mit Einverständnis des Betroffenen (Schweigepflicht!) können sie einbezogen und beraten werden, wie sie unterstützend begleiten, ohne zu überfordern. Ohne Zustimmung dürfen keine Details weitergegeben werden.

68 **D** Wirksamkeit zeigt sich an konkreten, beobachtbaren Verbesserungen: Selbstversorgung, Medikamententreue, sozialer Teilhabe, Tagesstruktur und Abwesenheit akuter Suizidalität. Solche Ziele werden gemeinsam überprüft und angepasst.

Auswertung

Richtig beantwortet	_____ von 68
Davon Teil A	_____
Davon Teil B	_____
Themen zum Wiederholen	_____

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.